

Afecções Benignas da pele e Tecido Celular Subcutâneo

Thiago Soares Gondim Medeiros

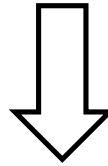
INTRODUÇÃO

- Existe uma grande variedade de lesões benignas da pele.
- São causadas pelo crescimento anormal das células de forma lenta e local.
- A maioria dos tumores de pele são benignos.
- Causas: Vírus, Doenças sistêmicas, Fatores genéticos, Fatores ambientais.

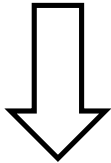
Nevos Melanocíticos

- São máculas, pápulas ou nódulos compostos por células pigmentares da pele.
- São classificados como congênitos ou adquiridos.
- São assintomáticos.
- Tratamento
 - Acompanhamento ambulatorial
 - Exérese cirúrgica.

Nevos Melanocíticos

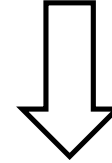


Congênitos



Pequeno < 1,5 cm
Médio: 1,5 a 20 cm
Grande > 20 cm

Adquiridos



Juncional
Intradérmico
Composto
Nevo Halo
Nevo Azul

Nevos Melanocíticos

CONGÊNITOS

- Lesões névicas presentes ao nascimento ou durante as primeiras semanas de vida.
- Prevalência variada na literatura.
- Classificados de acordo com seu tamanho
 - Pequeno < 1,5 cm
 - Médio: 1,5 a 20 cm
 - Grande > 20 cm



Nevos Melanocíticos

ADQUIRIDOS

- Lesões redondas ou ovais, com bordas bem definidas e que medem entre 2-6 mm.
- Desenvolvem-se desde a infância.
- Fatores étnicos, genéticos e ambientais.



Nevos Melanocíticos

NEVO JUNCIONAL

- Lesões maculares marrom claro até quase negro.
- Medem de 2-5 mm
- São redondas ou ovais
- Ninhos de melanócitos na junção demoepidermica.



Nevos Melanocíticos

NEVO INTRADÉRMICO

- Lesões papulares com coloração castanho claro.
- Pode ser liso, piloso ou verrucoso.
- Melanócitos e células névicas confinados quase inteiramente na derme.



Nevos Melanocíticos

NEVO COMPOSTO

- Lesões papulares.
- Marrom claro a escuro.
- Discretamente ou muito elevados.
- Ninhos de melanócitos na junção demoepidérmica e na derme.



Nevos Melanocíticos

NEVO HALO

- Qualquer tipo de Nevos circundado por um anel de pele despigmentado.
- Pode ser liso, piloso ou verrucoso.
- Inflamação e perda de melanócitos no halo da pele.



Nevos Melanocíticos

NEVO AZUL

- Lesão papular ou nodular.
- Cinza-azulado.
- Geralmente liso, mas pode ser ligeiramente elevado.
- Melanócitos dérmicos fusiformes associados a melanina e colágeno.



Classificação dos nevos



Tipo	Características clínicas	Histologia
Nevo juncional	Marrom-claro até quase negro Em geral, aplanado, mas pode ser ligeiramente elevado; 1-10 mm	Ninhos de melanócitos na junção dermoepidérmica
Nevo composto	Marrom-claro a escuro Pode ser discretamente ou muito elevado; 3-6mm	Ninhos de melanócitos na junção dermoepidérmica e na derme
Nevo intradérmico	Cor da pele a marrom; pode ser liso, piloso ou verrucoso Elevado; 3-6 mm	Melanócitos e células névicas confinadas quase inteiramente na derme
Nevo halo	Qualquer tipo de nevo circundado por um anel de 2 a 6 mm de pele despigmentada	A mesma que para outros nevos, mas com inflamação e perda de melanócitos no halo da pele
Nevo azul	Cinza-azulado Geralmente liso, mas pode ser ligeiramente elevado; 2 a 4 mm	Melanócitos dendríticos profundamente pigmentados e melanófagos dispersos na derme

Nevos Melanocíticos

	Assimetria	Borda	Cor	Dimensão	Evolução
	Simétrico	Regular	Tom único	Inferior à 6mm	Não cresce nem muda de cor
BENIGNO					
	Assimétrico	Irregular	Dois ou mais tons	Superior à 6mm	Cresce e muda de cor
MALIGNO					

Verrugas

- São lesões epidérmicas benignas.
- Trata-se de uma Hiperplasia Epidérmica Papilomatosa.
- Associadas à infecção pelo papiloma vírus humano
- Tratamento cirúrgico, uso de medicamentos ou crioterapia.



Lipoma

- São tumores benignos compostos por células de tecido adiposo.
- Podem aparecer em qualquer região do corpo
- Não se conhece a causa
 - Genética
 - Trauma
 - Obesidade
- São assintomáticos e mais comum no sexo feminino

Lipoma

- Aspecto arredondado
- Bordas regulares
- Crescimento lento
- Indolores
- Consistência amolecida.



Lipoma



Cisto Epidérmico

- É conhecido como cisto sebáceo
- Nódulo subcutâneo Benigno
- São mais frequentes na face, pescoço e tronco.
- São mais comuns em adultos

Cisto Epidérmico

- Lesão nodular subcutânea
- Presença de orifício puntiforme central
- Cor da pele
- Tamanho variável
- Indolores
- Consistência dura e elástica.



Cisto Epidérmico



Cisto Triquilemal

- Cisto Benigno
- Mais frequente no couro cabeludo.
- São mais comuns em mulheres
- Podem ser únicos ou múltiplos

Cisto Triquilemal

- Formato arredondado
- São moveis
- Tamanho variável
- Indolores
- Consistência elástica.
- Tratamento:
 - Exérese cirúrgica.



Xantelasma

- Placas amareladas de depósito de gordura.
- Acometem as pálpebras
- Tamanho variável
- Indolores
- Tratamento:
 - Exérese cirúrgica.



Acrocórdon

- Lesões fibroepiteliais benignas.
- Assintomáticos
- Mais comum no pescoço, axila, pálpebras.
- Tratamento:
 - Exérese cirúrgica.



Dermatofibroma

- Lesões benignas causadas por depósito de fibrina.
- São assintomáticos
- Mais comum nas extremidades.
- Tratamento:
 - Exérese cirúrgica.



OBRIGADO